

DILIGENCIAMIENTO DE INFORME NEUROPSICOLÓGICO CON EVALUACIÓN COGNITIVA DE WISC IV- NIÑOS

Se debe hacer análisis funcional de acuerdo con la complejidad de los procesos (Bottom Up, jerarquía funcional). Si algo se puede explicar desde un proceso más básico, no se explica desde los de alto nivel (no se habla de SAS si la falla es en velocidad, se explica el impacto de este proceso básico sobre los superiores). Se deben aclarar interferencias de otros procesos sobre la función evaluada (aspectos emocionales, motivacionales, motores o sensoriales que afecten la ejecución, que no se expliquen desde la función principal evaluada, por ejemplo, inquietud por ansiedad y no por hiperactividad o fallas de atención, por ejemplo, o bajo tono que afecta lo visográfico sin ser falla práxica).

- ❖ En los niños NUNCA se debe usar el “conserva” o “preserva”, porque es desarrollo y no una pérdida de la función. Y Se usa el prefijo DIS, en vez de A, p.e. disfasia en vez de afasia.
- ❖ NO REPETIR INFORMACIÓN. Si ya está la gráfica indicando si le fue bien o mal en un puntaje, no volverlo a poner en el informe – pueden remitir a la gráfica si así lo desean-.
- ❖ NO HABLAR DE LA PRUEBA SI NO DE LA FUNCIÓN COGNITIVA.
- ❖ TENER SIEMPRE PRESENTE EL MOMENTO DEL DESARROLLO. Si una condición implica varios procesos del desarrollo y condiciones se considera explicativo de afectación de procesos más básicos que los cognitivos y no se constituye en una suma de diagnósticos (p.e. sí tiene síntomas de TDAH, pero además tiene alteraciones de la coordinación, dispraxia o fallas del lenguaje, NO ES UN TDAH).
- ❖ Considerar lo revisado en algoritmos diagnósticos para la toma de decisiones diagnósticas.

Apartados del análisis en el informe

OBSERVACIÓN CLÍNICA: Partir del estado general del usuario, alertamiento, movilidad y disposición para la consulta, al ser niños con quien asisten. Luego describir con claridad las condiciones motoras, sensoriales y especialmente las conductuales emocionales que sean relevantes para el análisis, cambios en el patrón de comportamiento con o sin el cuidador y actitud hacia el proceso.

ATENCIÓN: Red de vigilancia Alerta tónica y fásica (Modelo de Posner), Atención focal (Span – dígitos directos ENI-, orientación/focalización), velocidad de procesamiento de base – considerar el rendimiento en el índice de velocidad, junto con el análisis en todas las pruebas que impliquen tiempos límites y latencias de respuesta-. Atención sostenida - usamos Clave de Números como predictor del funcionamiento, pero analizamos clínicamente cómo se sostiene en tareas continuas- y selectiva – considerando Búsqueda de

símbolos, así como la sensibilidad a estímulos ya sea externos o autogenerados- (Se analiza de acuerdo con modelo de Solberg y Mateer). Sistema Atencional Superior, sí aplica.

MEMORIA: se pone N/A, porque en el WISC básico no aplicamos pruebas de memoria.

PRAXIAS/GNOSIAS: Se debe iniciar estableciendo una buena funcionalidad sensorperceptual o motora, de lo contrario describir la base de estas funciones (p.e. si hay bajo tono, y si hay deficiencias sensoriales, agarre del lápiz, postura, etc). Describir la ejecución en cubos, qué aspectos evidencian el buen o mal rendimiento, se deben analizar aspectos como el análisis y la síntesis visuales, así como la manipulación, ubicación y lateralidad como posibles interferencias.

LENGUAJE: Se inicia analizando el lenguaje espontáneo en sus aspectos expresivo (Iniciativa, fluidez, articulación, sintaxis, prosodia, semántica y pragmática) y comprensivo (Comprensión del discurso y preguntas, hilo de la conversación. Seguimiento de instrucciones simples y complejas)- usar el modelo de Ellis y Young ampliado-. Se analiza la conceptualización verbal asociada a la prueba de vocabulario, partiendo de si tiene el léxico y cuál puede ser el fallo cuando tenga un bajo rendimiento en la prueba.

FUNCIONES EJECUTIVAS: Se debe analizar categorización (semejanzas, conceptos con dibujos), desde los niveles básicos de asociación, hasta la abstracción si aplica. Memoria de trabajo verbal (incluir en qué proceso hay fallo; sostenimiento, uso de la información, operaciones, si es aritmética si falla en la representación mental de las cantidades). Diferenciar, si es el caso lo visual vs. lo verbal. Razonamiento no verbal (matrices) indicando el tipo de procesos (igualación, emparejamiento, secuenciación, etc). En todos los anteriores revisar las posibles interferencias (p.e. si falla en matrices no por razonamiento, si no por impulsividad). Comprensión social o juicio (planteamiento de soluciones de problemas, evaluación de consecuencias). Se debe incluir el análisis de las habilidades de autorregulación (impulsividad motora o cognitiva, planeación, metacognición, etc), - emplear categorización de las Funciones ejecutivas específicas vs. cibernéticas, así como mediación del lenguaje como regulador de la conducta particularmente en el desarrollo, como se plantea en los modelos de Luria-.

FUNCIONALIDAD: El análisis de los aspectos más relevantes de las escalas, si hay coordinación o no entre lo reportado y lo observado, o lo reportado en la entrevista, sin nombrar de nuevo el nombre de las escalas.

COCIENTE INTELECTUAL: En este apartado ya aparecen por defecto los puntajes, entonces no se deben repetir. La idea es analizar cuantitativamente el perfil intelectual, homogéneo vs. discrepante, tendencias, fortalezas y dificultades desde los puntajes.

I.DX.: Empezar analizando el CI (por defecto va a aparecer el CI y los índices, y los complementarios si aplica), como se interpreta o se entiende el perfil intelectual. Posteriormente la explicación del funcionamiento cognitivo identificado (las fallas o dificultades base que explican a las demás), para cerrar concluyendo el perfil con qué diagnóstico se corresponde, responder al motivo de consulta y dar recomendaciones puntuales más relevantes en las que queremos enfocar.

RECOMENDACIONES: Ajustar las posibles remisiones, luego recomendaciones terapéuticas, cognitivas orientadas a casa y escuela. Tiempo de control o si es el caso, necesidad de evaluación complementaria.

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	Versión
Cargo: Dirección Clínica	Cargo: Dirección Clínica	Cargo: Dirección Clínica	V.1. 18 de noviembre de 2024
Nombre: Ma. Cristina Pinto	Nombre: Susana Lozano	Nombre: Ma. Cristina Pinto Susana Lozano	